Diagrammes et tableaux

Anzahl der Aufgaben: 18 Temps: 45 minutes

1. La Ligue suisse contre le cancer a réparti la fréquence (incidence) et la mortalité (mortalité) de tous les types de cancer par sexe. (Source : Ligue suisse contre le cancer)

Les types de cancer les plus fréquents, par sexe (incidence)

Hommes			Femmes	
Cancer de la prostate	30%	§	Cancer du sein	32%
Cancer du poumon	11%		Cancer du côlon	10%
Cancer du côlon	10%		Cancer du poumon	10%
Cancer de la peau (mélanome)	7%		Cancer de la peau (mélanome)	7%
Cancer de la vessie	4%		Cancer du corps utérin	5%

§ *Exemple de lecture: 30% de tous les cas de cancer parmi les hommes concernent la prostate.*

Les types de cancer présentant la plus grande mortalité, par sexe

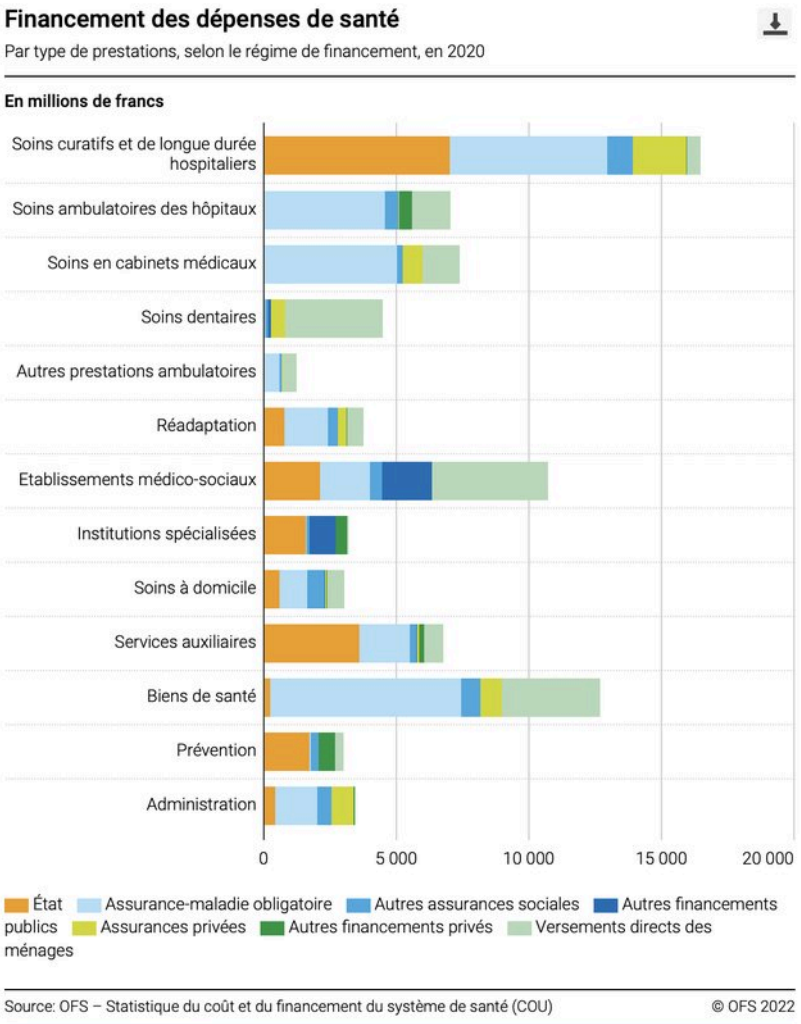
Hommes			Femmes	
Cancer du poumon	21%	#	Cancer du sein	18%
Cancer de la prostate	15%		Cancer du poumon	17%
Cancer du côlon	10%		Cancer du côlon	10%
Cancer du pancréas	7%		Cancer du pancréas	9%
Cancer du foie	5%		Cancer de l'ovaire	5%

Exemple de lecture: 21% de tous les hommes qui décèdent par suite d'un cancer meurent de cancer du poumon.

Que peut-on déduire de cette représentation ?

A. Le système reproducteur est plus souvent touché par le cancer en raison de l'augmentation du métabolisme cellulaire.
B. Le cancer du côlon est celui qui tue le plus de personnes après le cancer du sein ou de la prostate.
C. Environ 40% de tous les cancers chez les hommes concernent les poumons ou la prostate.
D. Le cancer de la vessie ne touche pas les femmes.
E. Si le nombre de femmes et d'hommes dans une population est égal, environ 10% de la population décède d'un cancer du côlon.

2. Le diagramme suivant montre de quelle manière sont financées les différentes catégories de coûts de la santé en Suisse en 2020.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peut/peuvent être déduite(s) de la représentation ?

I. Le soutien de l'Etat représente une part plus importante pour les traitements curatifs stationnaires que pour toutes les autres catégories.

II. Ce sont surtout les traitements dentaires qui sont le plus souvent payés par les patients eux-mêmes.

III. En 2020, plus de 5000 traitements ambulatoires ont été effectués dans des cabinets médicaux.

(A) Toutes les affirmations

(B) Affirmation III uniquement

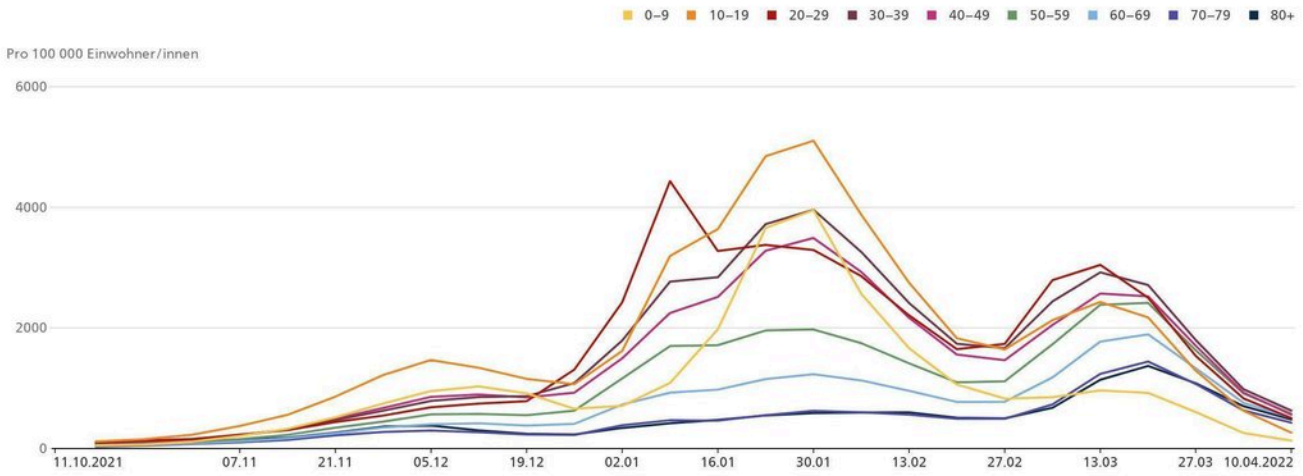
(C) Affirmation II uniquement

(D) Affirmations II & III

(E) Aucune des affirmations

3. Le virus "Sars-CoV-2" est l'agent infectieux qui provoque la maladie infectieuse Covid-19. Ce virus est responsable de la pandémie mondiale de coronavirus qui a commencé au printemps 2020.

   Le diagramme suivant montre les cas d'infection par le Sras-CoV-2 confirmés en laboratoire en Suisse et au Liechtenstein dans différentes classes d'âge entre le 11.10.2021 et le 10.04.2022 par 100'000 habitants.



Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du diagramme ci-dessus ?

A. En Suisse et au Liechtenstein, il n'y a jamais eu plus de 6 000 cas d'infection par le Sras-CoV-2 signalés au cours de cette période.

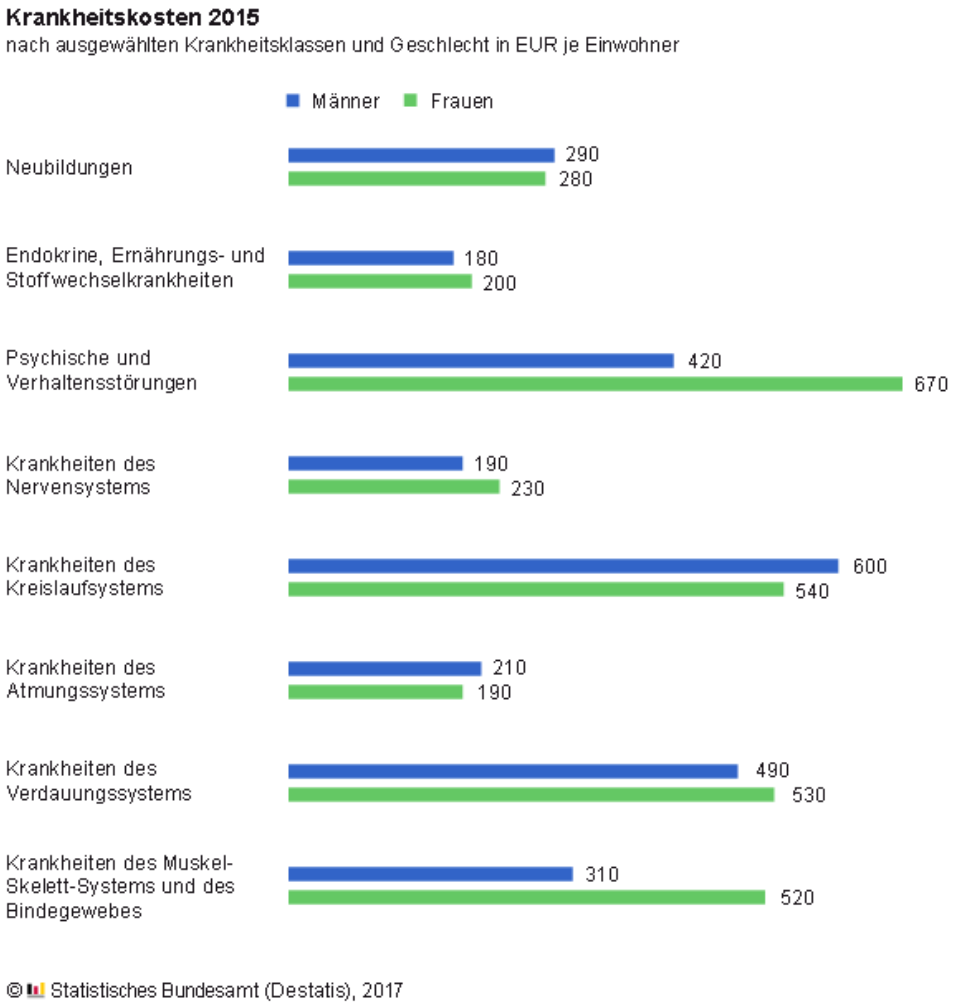
B. Le 30 janvier 2022, le plus grand nombre d'infections par le Sras-CoV-2 de toute la pandémie de coronavirus a été déclaré dans le groupe d'âge 10-19.

C. Dans le groupe d'âge 0-9, il n'y a jamais eu plus d'infections par le Sras-CoV-2 déclarées pour 100 000 habitants que dans le groupe d'âge 10-19 au cours de cette période.

D. Dans le groupe d'âge 50-59, le nombre de cas déclarés n'a jamais dépassé 2 000 pour 100 000 habitants.

E. Entre le 11.10.2021 et le 02.01.2022, aucun groupe d'âge n'a enregistré plus de 2 000 infections par le Sras-CoV-2 pour 100 000 habitants.

4. L'Office fédéral allemand de la statistique a publié en 2017 les coûts des maladies de la population allemande pour l'année 2015. Ceux-ci ont été répartis entre les différentes classes de maladies et en outre séparés par sexe.



Que peut-on déduire de cette illustration ?

(A) Les maladies psychiques (psychische und verhaltensstörungen) sont plus souvent diagnostiquées chez les femmes.

(B) Le traitement des maladies cardiovasculaires (Kreislaufsystems) chez les hommes est en comparaison le plus coûteux.

(C) Les maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque sont plus coûteuses.

(D) Les maladies endocriniennes, nutritionnelles (Ernährungs) et métaboliques (Stoffwechsel) ont généré le moins de coûts dans le système de santé allemand en 2015.

(E) Les femmes génèrent en moyenne plus de coûts engendrés par la maladie, car elles vivent plus longtemps.

5. Le diagramme suivant montre la consommation annuelle de boissons alcoolisées par habitant en Suisse entre 1990 et 2010 en litre d'alcool pur par habitant.

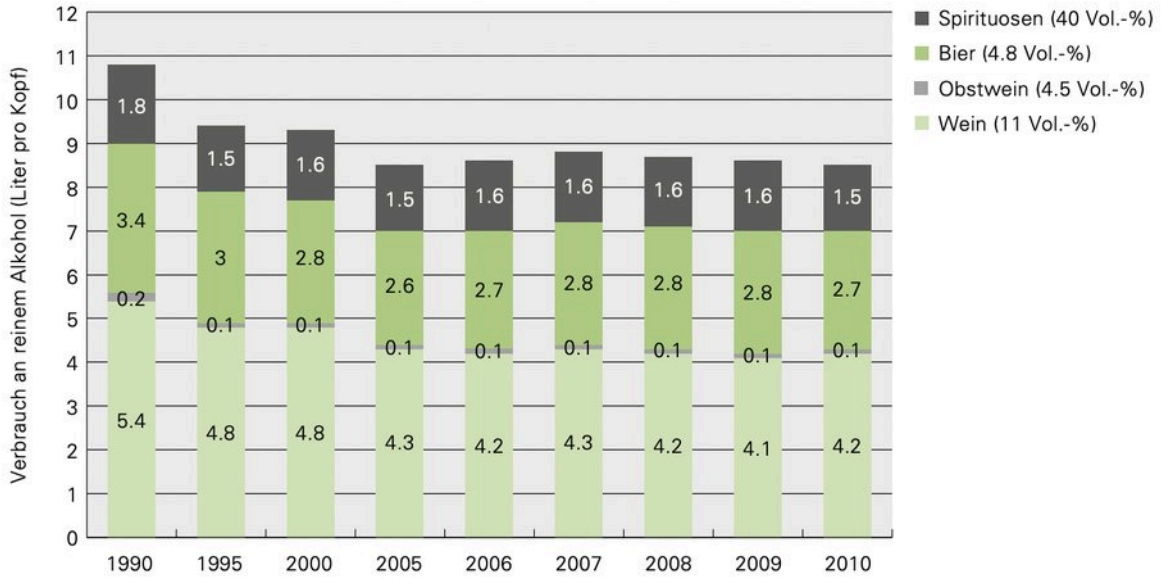


Abbildung 2.4: Jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch alkoholischer Getränke in der Schweiz zwischen 1990 und 2010 (Liter reiner Alkohol; 27)

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du diagramme ?

I. La consommation totale d'alcool pur par habitant a diminué d'environ 3,2 litres entre 1990 et 2010, alors qu'elle était jusqu'alors de près de 11 litres.

II. L'alcool de fruits (Obstwein) est consommé au maximum 0,2 litre par an.

III. En 2009, il y avait plus de consommation d'alcool pur par habitant qu'en 2008.

(A) Toutes les affirmations

(B) Affirmation III uniquement

(C) Affirmation II uniquement

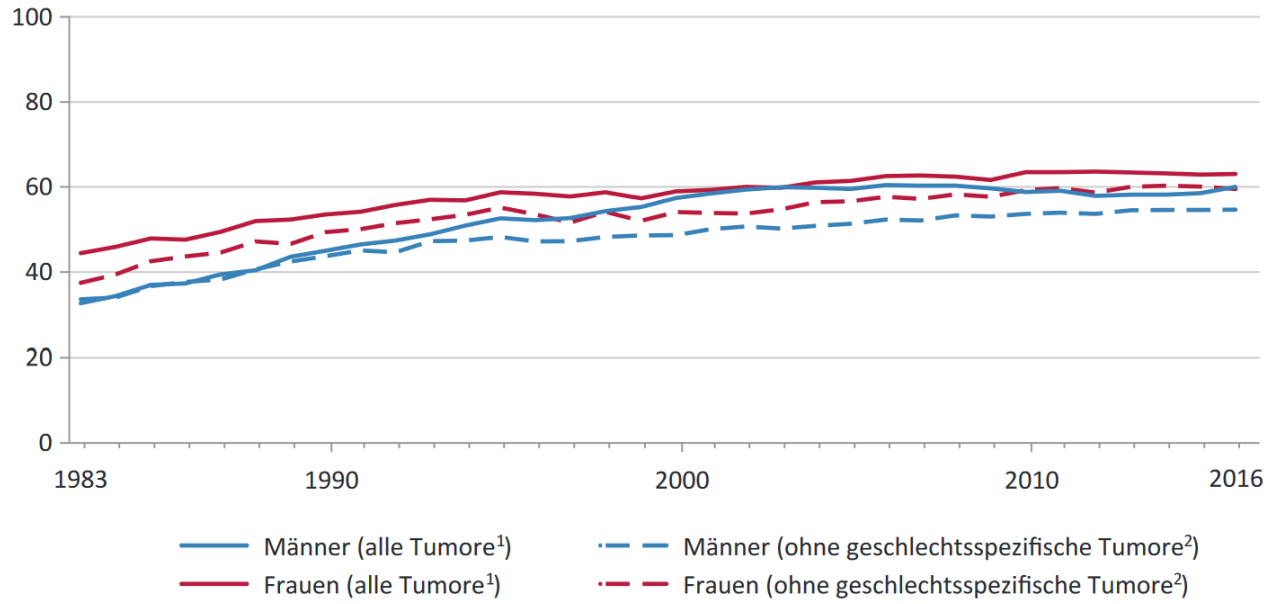
(D) Affirmations II & III

(E) Aucune des affirmations

6. Le taux de survie à cinq ans est utilisé en épidémiologie pour donner des indications sur le pronostic après un diagnostic de maladie, surtout après un diagnostic de cancer. Le taux de survie à cinq ans, qui est généralement exprimé en pourcentage, indique combien de patients sont encore en vie cinq ans après le diagnostic de leur maladie.

   Ce graphique montre la survie relative à cinq ans après un diagnostic de cancer (relative Fünfjahres-Überleben nach einer Krebsdiagnose) en Autriche entre 1983 et 2016. Les données proviennent du registre autrichien du cancer.

Relatives Fünfjahres-Überleben nach einer Krebsdiagnose, 1983 bis 2016

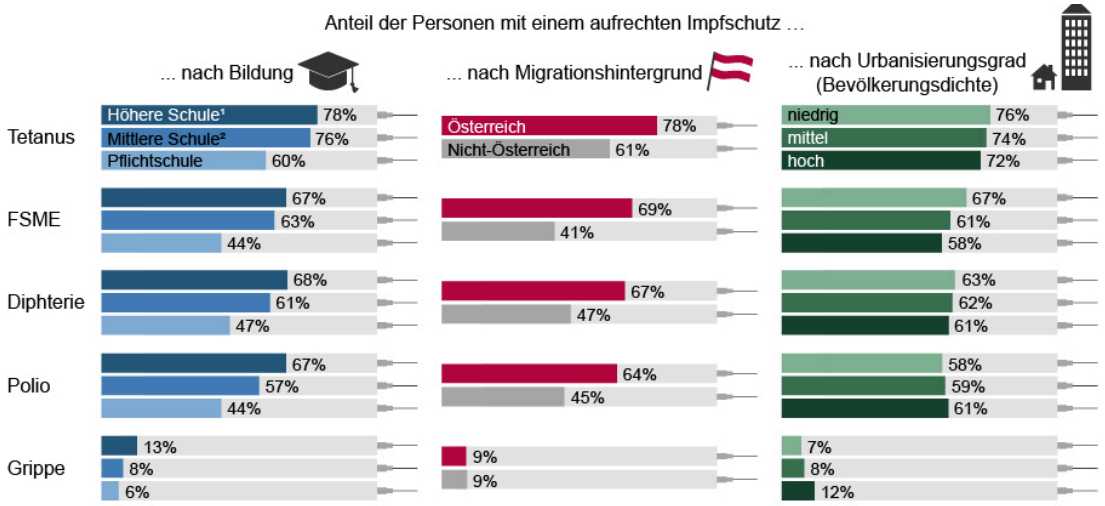


Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (19.01.2022) und Todesursachenstatistik. – Ende des Follow-up 31.12.2020. – 1) Maligne invasive Fälle ohne sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C00–C96, ohne C44) und ohne DCO-Fälle. – 2) Maligne invasive Fälle ohne Brustkrebs, Krebs der weiblichen und männlichen Genitalorgane (C50, C51–C58, C60–C63), ohne sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C44) und ohne DCO-Fälle.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du diagramme ?

A. La survie relative à cinq ans des hommes autrichiens a augmenté de 25% au cours de la période observée, pour atteindre 60% en 2016, contre environ 35% en 1983.
B. Ce diagramme ne permet pas de se prononcer sur l'évolution des "autres tumeurs malignes de la peau" («sonstigen bösartigen Neubildungen der Haut»)
C. En 2003, les femmes et les hommes autrichiens chez qui un cancer a été diagnostiqué avaient la même probabilité d'être encore en vie en 2008.
D. Les femmes autrichiennes chez qui une tumeur non spécifique au sexe (nicht-geschlechtsspezifischer Tumor) a été diagnostiquée en 1995 ou en 2013 ont plus de chances d'être encore en vie après 5 ans que les hommes chez qui une tumeur non spécifique au sexe a été diagnostiquée au cours de ces années.
E. Depuis 1989, les hommes autrichiens ayant reçu un diagnostic de cancer ont un pourcentage de survie à cinq ans supérieur à celui des hommes ayant reçu un diagnostic de tumeur non spécifique au sexe.

7. Le graphique suivant illustre le nombre de personnes vaccinées en Autriche. Les données ont été classées en fonction de l'éducation, de l'origine migratoire et de la densité de population du lieu de résidence, ainsi que des vaccins concernés.



Quelle und Grafik: STATISTIK AUSTRIA, Gesundheitsbefragung 2019. Altersstandardisierte Prozentwerte. Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 und mehr Jahren. – ¹ Höhere Schule/Akademie/Hochschule. – ² Lehre/berufsbildende mittlere Schule. – Erstellt am 15.01.2021.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du graphique ?

(A) Les personnes issues de l'immigration (Personen mit Migrationshintergrund) sont moins nombreuses à être vaccinées contre le tétanos que les personnes non issues de l'immigration.

(B) Les personnes ayant fait des études supérieures (Bildung einer höheren Schule) sont plus souvent vaccinées, car elles sont mieux informées.

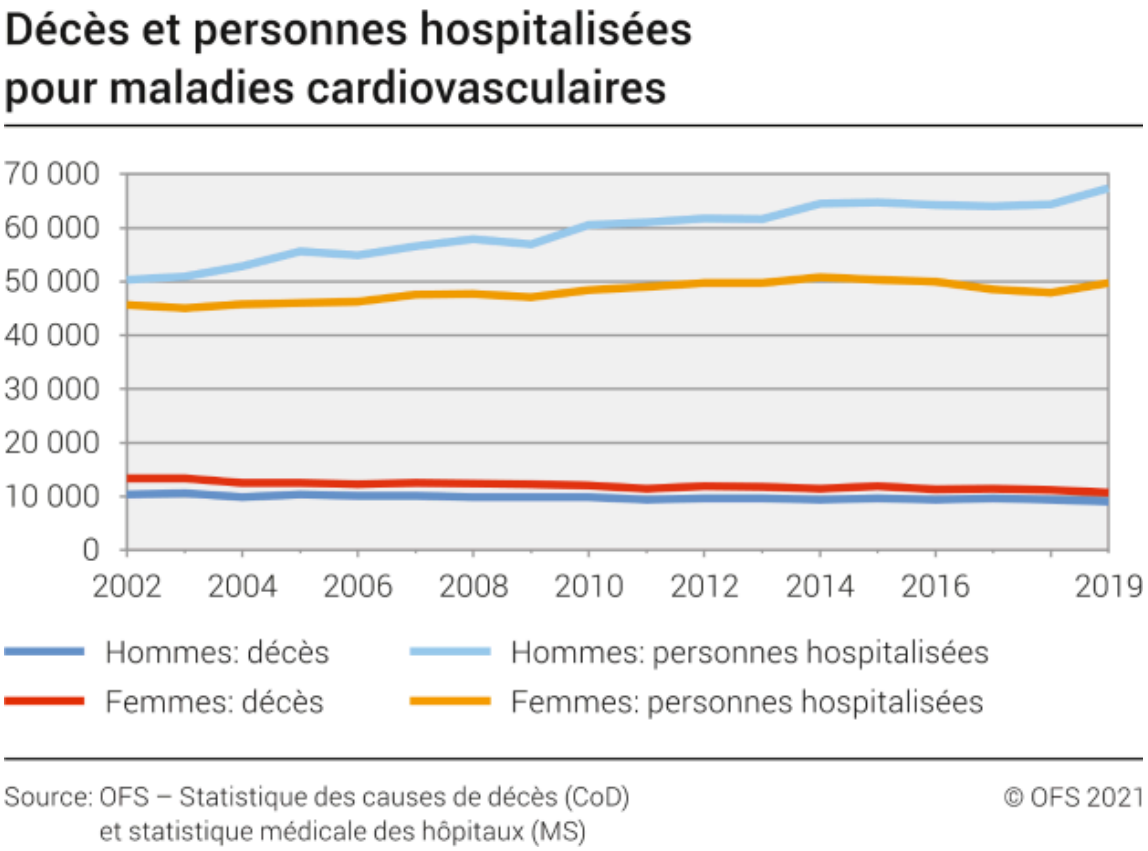
(C) A l'exception de la polio, les personnes résidant dans des régions à forte densité de population (Wohnort in hoch Bevölkerungsdichten Regionen) sont proportionnellement moins souvent vaccinées.

(D) Il y a autant de personnes ayant un niveau d'éducation élevé que de personnes vivant dans des régions à faible densité de population qui sont vaccinées contre la FSME.

(E) La vaccination contre le tétanos est comparativement plus fréquente dans tous les contextes.

8. Les maladies du système cardiovasculaire, comme l'hypertension, l'infarctus du myocarde ou l'endocardite, font partie des principales causes d'hospitalisation ou de décès des patients.

   Le graphique suivant montre le nombre d'hospitalisations et de décès dus à des maladies cardiovasculaires chez les femmes et les hommes entre 2002 et 2019.



I. Jusqu'à présent, le nombre d'hommes hospitalisés n'a cessé d'augmenter.

II. Au cours de la période observée, en 2010, plus de 60 000 hommes sont décédés pour la première fois en raison d'une maladie cardiovasculaire.

III. Entre 2002 et 2019, aucune année n'a vu plus de femmes hospitalisées que d'hommes.

IV. En 2019, environ 50 000 femmes ont été hospitalisées pour un infarctus du myocarde.

Que peut-on déduire de l'illustration ci-dessus et des affirmations qui y sont associées ?

A. Seule l'affirmation I peut être déduite.

B. Seule l'affirmation III peut être déduite.

C. Les affirmations I à III peuvent être déduites.

D. Les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.

E. Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

9. Le diagramme suivant illustre l'espérance de vie par âge des hommes résidant dans le canton de Thurgovie. Il montre le nombre moyen d'années supplémentaires auquel les différents groupes d'âge peuvent s'attendre entre 1989/1990 et 2019/2020.

Espérance de vie en fonction de l'âge
Canton de Thurgovie, 1989/1990-2019/2020, espérance de vie en années

	Hommes				
		A l'âge de			
	A la naissance	15 ans	45 ans	65 ans	80 ans
1989/1990	74.5	60.2	32.4	15.4	7.0
1999/2000	76.9	62.5	33.9	16.6	7.1
2009/2010	80.1	65.3	36.5	18.8	8.4
2014/2015	80.4	66.1	37.2	19.4	8.5
2015/2016	81.4	66.8	37.7	19.8	8.7
2016/2017	81.5	66.9	37.8	19.8	8.6
2017/2018	81.4	66.8	37.6	19.7	8.8
2018/2019	81.7	66.9	37.8	19.9	8.9
2019/2020	81.1	66.7	37.6	19.6	8.6

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du diagramme ?

(A) Les hommes de 80 ans ont une espérance de vie plus élevée en 2019/2020 que les nouveaux-nés de sexe masculin dans ces années-là

(B) En 2019/2020, l'espérance de vie en Thurgovie est de 82,6 ans pour les personnes âgées de 45 ans.

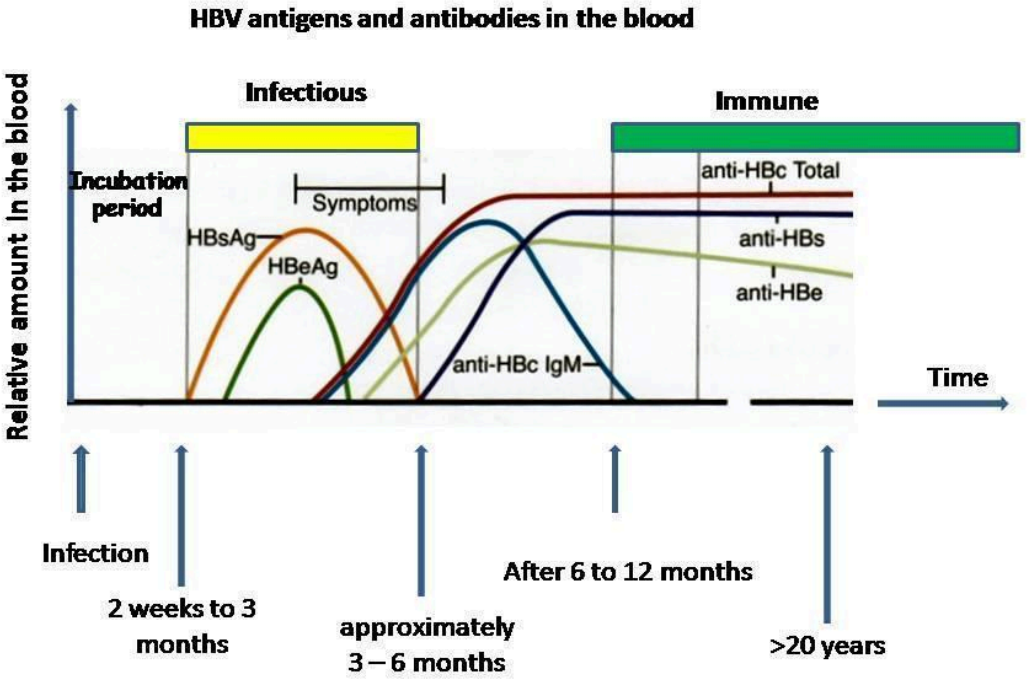
(C) De 1989/1990 à 2018/2019, chaque intervalle de 2 ans a vu l'espérance de vie augmenter chez les hommes.

(D) Dans cet intervalle de 30 ans, de 1989/1990 à 2019/2020, l'espérance de vie à la naissance pour les hommes a augmenté de plus de 5 ans.

(E) Ce tableau ne permet pas de tirer des conclusions sur l'espérance de vie des hommes dans l'ensemble de la Suisse.

10. L'hépatite B est une forme d'hépatite virale provoquée par le virus de l'hépatite B ("HBV"). Le HBV se compose de différents antigènes (Ag) : les "antigènes de surface" (HBsAg), les "antigènes nucléaires" (HBcAg) et les "antigènes d'enveloppe" (HBeAg). Lors d'une infection par le HBV, après la période d'incubation, la réponse immunitaire de l'organisme produit des anticorps contre ces antigènes : les anti-HBs, les anti-HBc et les anti-HBe. Parmi les anti-HBc, on distingue en outre les anti-HBc IgM et les anti-HBc Total.

    Ce diagramme montre schématiquement les quantités relatives d'antigènes et d'anticorps du HBV dans le sang après une infection par le virus de l'hépatite B au fil du temps.



I. La durée de présence des antigènes d'enveloppe dans le sang est égale à la durée de la période d'incubation.

II. Au cours de la deuxième moitié de la période infectieuse, les symptômes apparaissent normalement, des anticorps sont produits et les antigènes diminuent.

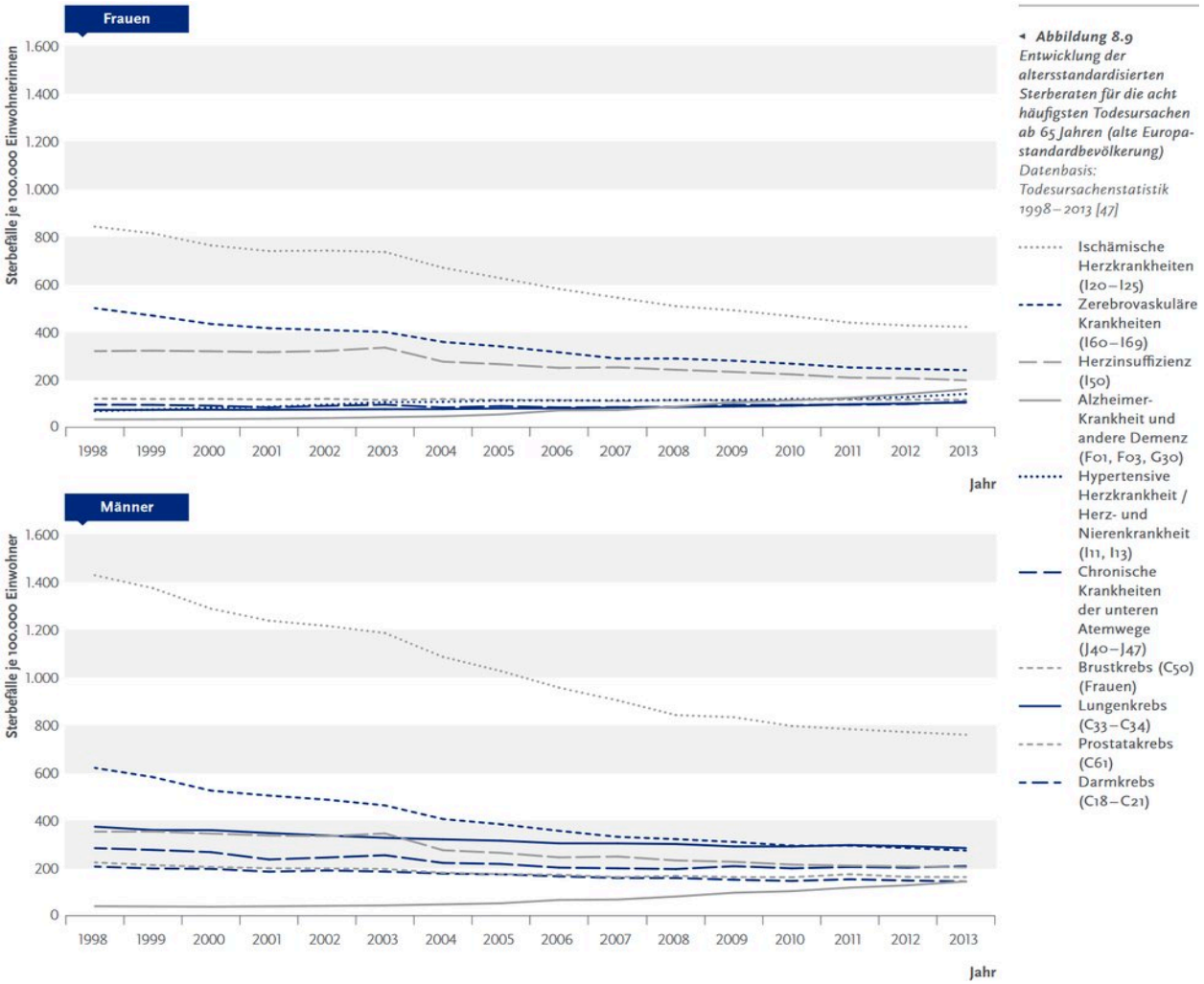
III. Les antigènes nucléaires ne disparaissent qu'après 6 à 12 mois, tandis que les antigènes de surface et les antigènes d'enveloppe disparaissent déjà après 3 à 6 mois.

IV. Les anticorps contre l'antigène dont la quantité relative est la plus élevée sont produits en dernier.

Quelle affirmation peut-on en déduire ?

a. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
b. Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
c. Seules les affirmations II et IV peuvent être déduites.
d. Seules les affirmations II-IV peuvent être déduites.
e. Aucune des affirmations ne peut être déduite.

11. Le diagramme suivant illustre l'évolution dans le temps des huit causes de décès les plus fréquentes chez les femmes et les hommes de 65 ans et plus en Allemagne entre 1998 et 2013 par 100’000 habitants.

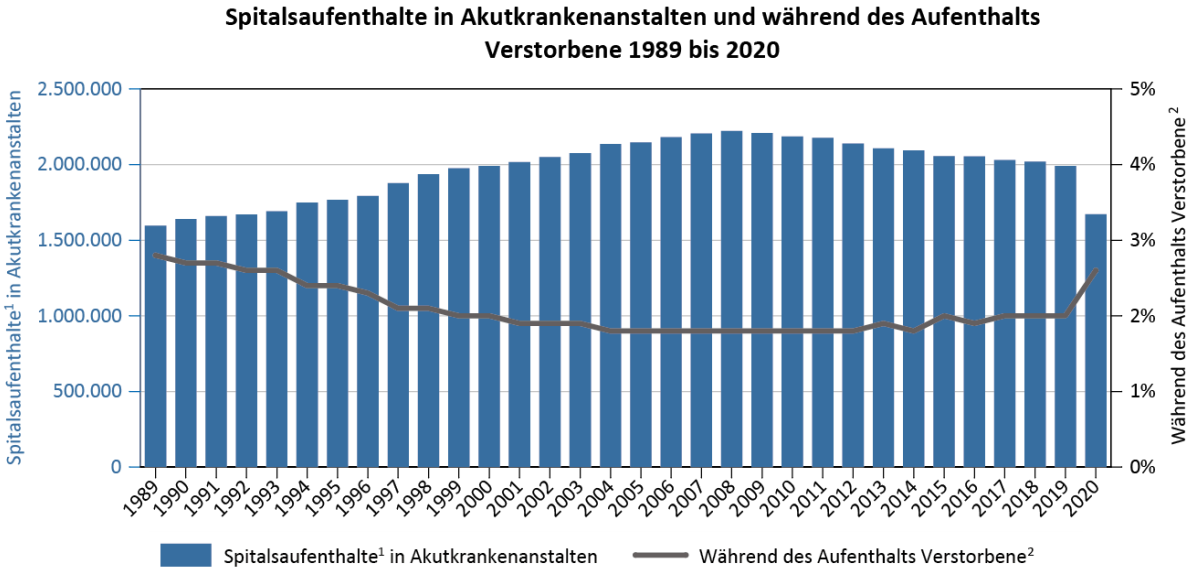


I. En 1998, en Allemagne, plus d'hommes sont décédés du cancer de la prostate que de femmes du cancer du sein (Brust).
II. Entre 1998 et 2013, les décès dus aux cardiopathies ischémiques (ischämischer Herzkrankheiten) chez les hommes de plus de 65 ans ont diminué de plus de 600 décès pour 100 000 habitants, grâce à l'amélioration des méthodes de diagnostic et à un plus large éventail d'options de traitement.
III. La maladie d'Alzheimer et autres démences est l'une des huit causes de décès les plus fréquentes qui a connu la plus forte augmentation en pourcentage de décès pour 100 000 habitants entre 1998 et 2013.
IV. Les décès pour 100 000 habitants dus à une insuffisance cardiaque (Herzinsuffizienz) ont atteint leur maximum pour les deux sexes au milieu de l'année 2003.

Quelle affirmation peut-on déduire du diagramme ci-dessus ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Seules les affirmations I à III peuvent être déduites.
C. Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
D. Seule l'affirmation III peut être déduite.
E. Aucune des affirmations ne peut être déduite.

12. Dans le diagramme ci-dessous, le nombre d'hospitalisations est comparé au taux de décès dans les hôpitaux (Anzahl Spitalaufenthalte mit der Todesrate).



Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik basierend auf Daten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Erstellt am 29.11.2021. – Bezugnahme auf Spitalsentlassungen von Personen mit Wohnsitz innerhalb und außerhalb Österreichs; inklusive Sterbefälle. – 1) Vollstationäre Aufenthalte (mit mindestens einer Übernachtung im Krankenhaus). – 2) Anteil der Spitalsentlassungen mit der Entlassungsart "verstorben" an allen Spitalsentlassungen.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite ?

(A) Le taux de mortalité (Verstorbene) n'est pas directement proportionnel au nombre d'hospitalisations (Spitalaufenthalte).

(B) C'est en 1989 que le plus grand nombre de personnes sont décédées à l'hôpital.

(C) De 1989 à 2008, le nombre d'hospitalisations n'a cessé d'augmenter.

(D) Durant la période décrite, il n'y a jamais eu plus de séjours hospitaliers qu'en 2008.

(E) En 2020, le nombre de personnes décédées à l'hôpital est supérieur à celui de l'année précédente par rapport au nombre d'hospitalisations.

13. Chaque année, plus de 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués. Plus d'une personne sur cinq est atteinte d'un cancer avant l'âge de 70 ans. Les cancers font donc parfois partie des causes de décès les plus fréquentes en Suisse.

    Le tableau suivant montre la moyenne annuelle des nouveaux cas de cancer diagnostiqués et des décès pour la période de 2014 à 2018 chez les hommes et les femmes en Suisse.

1.4 Cancer

Moyenne annuelle (pour la période 2014–2018)	Hommes		Femmes	
	Nouveaux cas	Décès	Nouveaux cas	Décès
Tous les cancers	23 653	9 461	19 969	7 715
Poumon, bronches, trachée	2 758	2 005	1 894	1 260
Sein			6 314	1 385
Prostate	6 649	1 352		
Côlon et rectum	2 529	933	1 978	751
Mélanome de la peau	1 614	183	1 389	127
Cancer chez les enfants[1] (tous types)	124	11	100	13

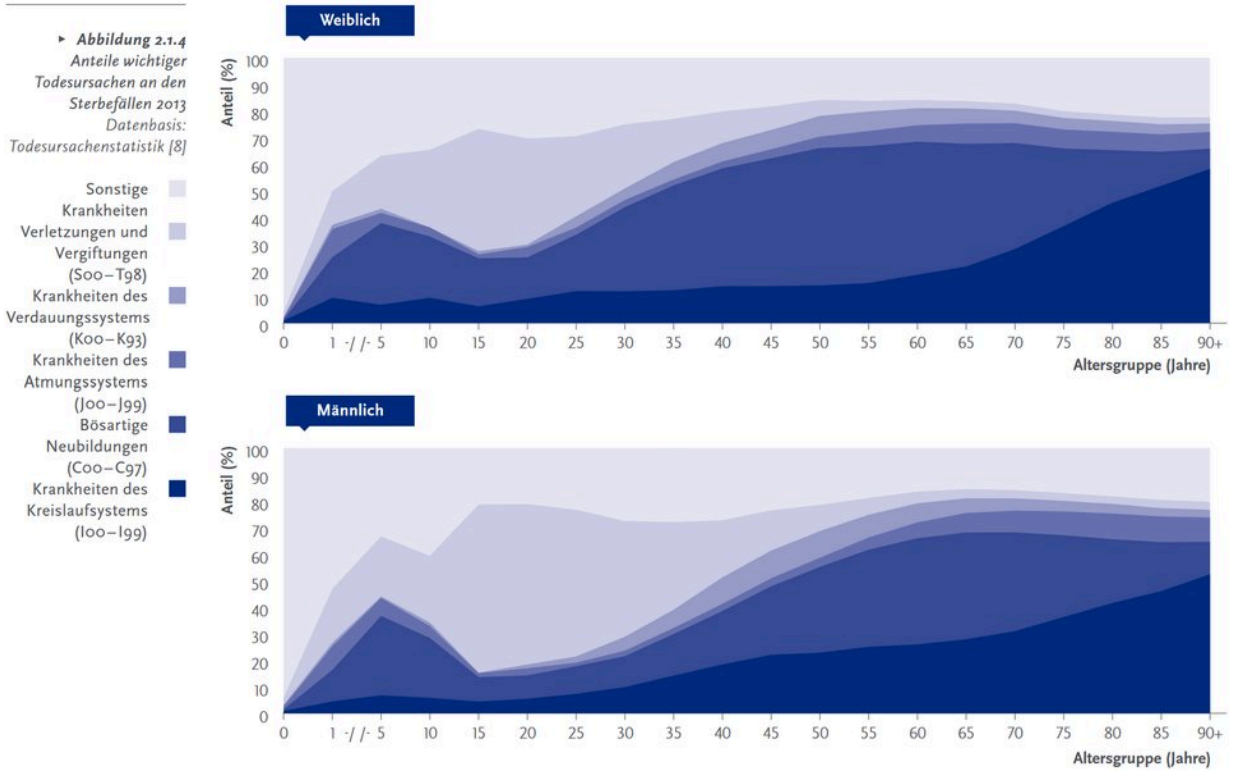
[1] 0–14 ans

Sources: OFS, ONEC, RCdE – Statistique nationale sur le cancer © OFS 2022

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du tableau ci-dessus ?

A. Hormis le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du côlon, le mélanome cutané et les cancers chez les enfants, il n'y a pas eu de nouveaux cas d'autres types de cancer en Suisse entre 2014 et 2018.
B. Entre 2014 et 2018, un total de 4 507 nouveaux cas de cancers du côlon ont été diagnostiqués.
C. Entre 2014 et 2018, en moyenne, exactement 100 femmes de moins de 18 ans ont été atteintes chaque année de tous types de cancer.
D. En moyenne, entre 2014 et 2018, trois fois plus d'hommes ont développé chaque année un cancer en Suisse que de femmes sont décédées en moyenne chaque année durant la même période en raison d'une maladie cancéreuse.
E. Le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en Suisse entre 2014 et 2018 est resté constant, tant chez les hommes que chez les femmes.

14. Le graphique suivant montre la proportion des principales causes de décès parmi les décès survenus en Allemagne en 2013 chez les hommes et les femmes de différents groupes d'âge.

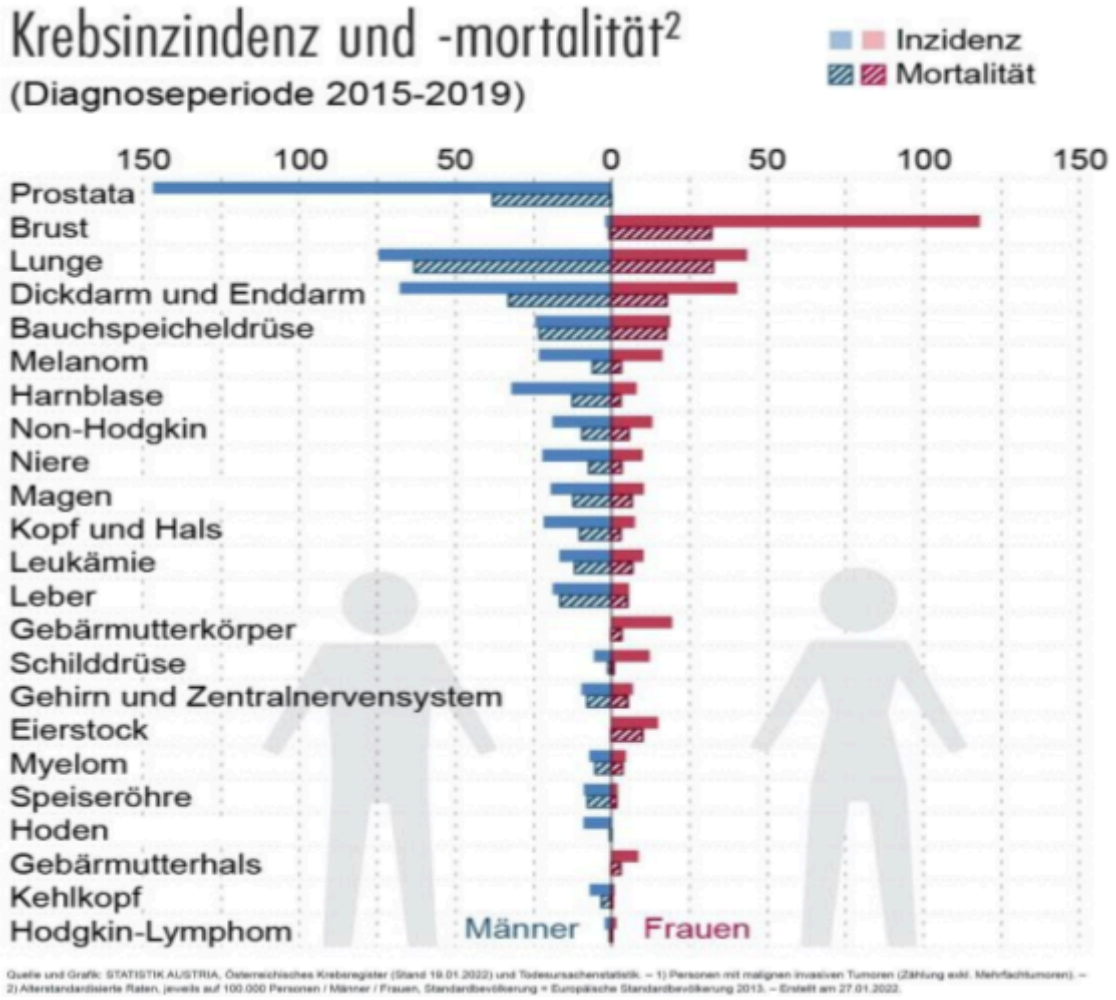


I. Parmi les personnes de plus de 90 ans décédées en Allemagne en 2013, les maladies de l'appareil circulatoire (Krankheiten des Kreislaufsystems) représentaient au moins 50% de toutes les causes de décès pour les deux sexes.
II. En dehors des maladies de l'appareil circulatoire, il n'existe aucune autre cause de décès pour laquelle le pourcentage de décès a augmenté chez les femmes âgées de 70 à 75 ans en Allemagne.
III. Les blessures et les empoisonnements (Verletzungen und Vergiftungen) ont atteint leur pourcentage maximal de décès en Suisse en 2013 chez les personnes de 15 ans des deux sexes, avec environ 45% chez les femmes décédées et environ 65% chez les hommes décédés.
IV. En Allemagne, les hommes de 50 ans sont décédés en 2013 à peu près aussi souvent de blessures et d'empoisonnements que de maladies du système digestif (Krankheiten des Verdauungssystems).

Quelle affirmation peut-on en déduire ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Seules les affirmations I, III et IV peuvent être déduites.
C. Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
D. Seules les affirmations I et IV peuvent être déduites.
E. Seule l'affirmation IV peut être déduite.

15. Le diagramme suivant présente la relation entre l'incidence (nombre de nouveaux cas de cancer dans la population définie) de différents types de cancer pour 100 000 personnes en Autriche et la mortalité respective (combien de décès surviennent en comparaison en raison du type de cancer). La létalité d'un type de cancer est la valeur qui décrit la fréquence à laquelle le cancer entraîne la mort et peut être déduite ici de la relation entre l'incidence et la mortalité.



Quelle und Grafik: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 19.01.2022) und Todesursachenstatistik. – 1) Personen mit malignen invasiven Tumoren (Zählung exkl. Mehrfachtumoren). – 2) Alterstandardisierte Raten, jeweils auf 100.000 Personen / Männer / Frauen, Standardbevölkerung = Europäische Standardbevölkerung 2013. – Erstellt am 27.01.2022.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite de la représentation ?

A. Les hommes meurent plus souvent d'un cancer du foie (Leberkrebs) que les femmes.
B. Le cancer du poumon (Lungenkrebs) est l'un des cancers les plus mortels, tant chez les hommes que chez les femmes.
C. Il existe 3 types de cancer qui ne sont diagnostiqués que chez les femmes dans cette illustration.
D. Le cancer de l'œsophage (Speiseröhrenkrebs) est l'un des cancers les plus létal.
E. Le cancer de la vessie (Harnblasenkrebs) est plus rare chez les femmes que chez les hommes.

16. Le tableau suivant montre la prévalence et l'incidence du diabète de type 1 et de type 2 chez les enfants et les adolescents en Allemagne, réparties entre les différents Länder et l'Allemagne dans son ensemble, et sur des périodes individuelles.

▸ *Tabelle 2.5.1 Prävalenz und Inzidenz des Typ-1- und Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland Datenbasis: KiGGS 2003–2006 [35], KiGGS Welle 1 2009–2012 (eigene Berechnungen) und regionale Registerdaten und Studien [33, 36–40]*

DIABETES-TYP	LAND	ZEITRAUM	ALTER (JAHRE)	PRÄVALENZ (JE 100.000 PERSONEN)	INZIDENZ (JE 100.000 PERSONENJAHRE)	QUELLE
Typ-1-Diabetes	Nordrhein-Westfalen	2007	0 – 19	184		[33]
			0 – 4	34		
			5 – 9	140		
			10 – 14	248		
			15 – 19	278		
		1996 – 2007	0 – 14		20,4	[36]
			0 – 4		14,8	
			5 – 9		22,9	
			10 – 14		23,6	
	Baden-Württemberg	2000 – 2006	0 – 14		19,4	[37]
	Bremen	1999 – 2007	0 – 17		19,2	[38]
	Sachsen	1999 – 2008	0 – 14		17,5	[39]
Typ-2-Diabetes	Baden-Württemberg	2004/2005	0 – 20	2,3		[34]
			0 – 14	0,8		
			15 – 20	5,0		
	Nordrhein-Westfalen	2002 – 2010	5 – 19		1,1	[40]
Gesamt	Deutschland	2003 – 2006	0 – 17	140		[35]
	Deutschland	2009 – 2012	7 – 17	210		KiGGS Welle 1, 2009 – 2012 (eigene Berechnungen)

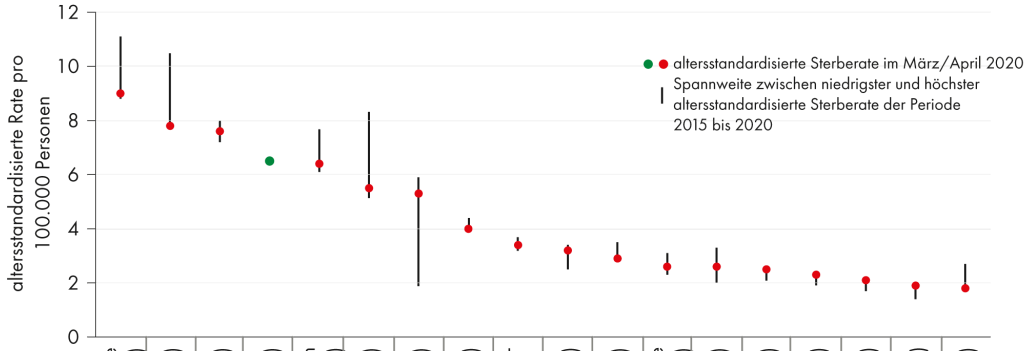
I. Entre 2009 et 2012, la prévalence d'un diabète chez les enfants âgés de 7 à 17 ans était supérieure de 50% à la prévalence d'un diabète chez les enfants âgés de 0 à 17 ans entre 2003 et 2006.
II. Entre 1996 et 2007, en Nordrhein-Westfalen, ce sont les enfants âgés de 10 à 14 ans qui ont le plus souvent développé un diabète de type 1.
III. Comparée au Bade-Wurtemberg et à la Nordrhein-Westfalen, la Sachsen compte le moins d'enfants âgés de 0 à 14 ans atteints de diabète de type 1.
IV. En 2007, le nombre d'enfants et d'adolescents atteints de diabète de type 1 en Nordrhein-Westfalen était exactement le même que le nombre total d'enfants et d'adolescents atteints de diabète en Allemagne entre 2003 et 2006.

Quelle conclusion peut-on tirer du tableau ci-dessus ?

A. Seule la proposition I peut être déduite.
B. Seules les propositions I-II peuvent être déduites.
C. Seules les propositions I-III peuvent être déduites.
D. Seules les propositions II-III peuvent être déduites.
E. Seules les propositions II-IV peuvent être déduites.

17. Le graphique suivant présente les taux de mortalité standardisés par âge pour les mois de mars et d'avril, avec la cause de décès correspondante. Le taux de mortalité 2020 est comparé au taux de mortalité des années précédentes.

Altersstandardisierte Sterberaten (ASR) in den Monaten März/April der Periode 2015 bis 2020* nach ausgewählten Todesursachen bzw. Todesursachengruppen



	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	Herzinfarkt (I21-I22)	Lungenkrebs (C33-C34)	COVID-19 (U07)	Chronische Atemwegserkrankungen exkl. Asthma (J40-J44, J47)	Diabetes (E10-E14)	Demenz (F01,F03)	Dickdarmkrebs (C18-C21)	Krebs der Bauchspeichel-drüse (C25)	Nierenkrankheit (N00-N29)	Brustkrebs (C50)	Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	Pneumonie (J12-J18)	Prostatakrebs (C61)	Alzheimer Krankheit (G30)	Morbus Parkinson (G20)	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	Selbsttötung (X60-X84, Y870)
Höchste ASR	11,1	10,5	8,0	6,5	7,7	8,3	5,9	4,4	3,7	3,4	3,5	3,1	3,3	2,6	2,4	2,2	1,9	2,7
Niedrigste ASR	8,8	7,8	7,2	6,5	6,1	5,1	1,9	3,9	3,2	2,5	2,9	2,3	2,0	2,1	1,9	1,7	1,4	1,8
ASR 2020	9,0	7,8	7,6	6,5	6,4	5,5	5,3	4,0	3,4	3,2	2,9	2,6	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,8

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik Stand 23.6.2020. – *) vorläufige Daten. – Vergleichsperioden März/April der Jahre 2015 bis 2019. – Ausgewählte häufige Todesursachengruppen, Gruppierung gemäß EUROSTAT-Liste, vereinfachter ICD-Text. – Eine nähere Beschreibung der medizinischen Angaben auf dem Totenschein und ihrer Kodierung finden Sie in den Informationen zur Methodik. – Lesebeispiel: Die altersstandardisierte Sterberate von Diabetes im März/April 2020 lag am unteren Rand der Spannweite zwischen dem niedrigsten und höchsten beobachteten Wert von März/April der vorangegangenen fünf Jahre. Erstellt am 08.07.2020.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite de la représentation ?

(A) Comme les jeunes patients meurent moins souvent de démence, les écarts entre les valeurs maximales (Spannweite) sont bien plus faibles que le taux de mortalité standardisé pour l'âge.
(B) Comme le COVID-19 n'existait pas avant 2020, aucune valeur comparative n'est disponible.
(C) En 2020, les maladies cérébrovasculaires (zerebrovaskuläre Krankheiten) avaient des taux de mortalité standardisés par âge plus élevés que les autres causes énumérées.
(D) Le suicide (Selbsttötung) n'est pas aussi mortel que les maladies cérébrovasculaires.
(E) En 2020, l'infarctus du myocarde (Herzinfarkt) était une cause de décès plus fréquente que les années précédentes.

18. Ce tableau montre le pourcentage de résistance de deux bactéries, E. coli et K. pneumoniae, à différents groupes d'antibiotiques en Suisse en 2017. Les deux bactéries ont été isolées à partir d'échantillons de sang et de liquide céphalorachidien ("CSF") (N = nombre d'échantillons isolés) et ont ensuite été testées pour leur résistance à différents antibiotiques.

    Un (R) signifie une résistance totale à cette bactérie, quel que soit le niveau de dose, un (I+R) signifie une résistance totale ou seulement un effet à forte dose de l'antibiotique.

Table 5.35 Percentages of resistance for *E. coli* and *K. pneumoniae* among blood and CSF isolates in Switzerland, 2017

	E. coli		*K. pneumoniae*	
Antibiotic (group)	**N**	**Resistance (%)**	**N**	**Resistance (%)**
Amoxicillin/ampicillin (R)[a]	5394	49	NA	NA
Amoxicillin-clavulanic acid (R)	5390	23	960	13
Piperacillin-tazobactam (R)	5372	4	959	5
Cefotaxime/ceftriaxone (R)[b]	5375	9	960	6
Cefotaxime/ceftriaxone (I+R)[b]	5375	9	960	7
Ceftazidime (R)	5372	7	947	6
Ertapenem (R)	4060	0	714	0
Imipenem/meropenem (R)[c]	5378	0	959	0
Imipenem/meropenem (I+R)[c]	5378	0	959	0
Gentamicin/tobramycin (R)[d]	5388	8	961	5
Amikacin (R)	3968	2	730	1
Ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin (R)[e]	5397	17	961	8
Ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin (I+R)[e]	5397	19	961	11
Multidrug resistance (R)[f]	5385	3	959	3

NA: not applicable.
[a] Amoxicillin and ampicillin are indicators for the group of aminopenicillins.
[b] Cefotaxime and ceftriaxone are indicators for the group of third-generation cephalosporins.
[c] Imipenem and meropenem are indicators for the group of carbapenems.
[d] Gentamicin and tobramycin are indicators for the group of aminoglycosides.
[e] Ciprofloxacin, levofloxacin and ofloxacin are indicators for the group of fluoroquinolones.
[f] Multidrug resistance is defined as resistance to ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin, cefotaxime/ceftriaxone/ceftazidime and gentamicin/tobramycin. Isolates with missing data on one or more of the groups were excluded.

I. En Suisse, des bactéries E. coli ont été isolées au moins 3 968 fois à partir du sang et du liquide céphalorachidien en 2017.
II. Les carbapénèmes sont, avec l'ertapénème, les seuls antibiotiques qui présentent un pourcentage de résistance de 0% à toutes les bactéries connues.
III. En 2017, il y avait en Suisse environ 5,6 fois plus de cas de résistance complète d'E. coli aux fluoroquinolones qu'il n'y avait de cas de résistance complète de K. pneumoniae aux fluoroquinolones.
IV. Environ 48 des K. pneumoniae isolés en Suisse en 2017 étaient totalement résistants aux antibiotiques aminoglycosides.

Quelle affirmation est correcte selon le tableau ci-dessus ?

A. Toutes les affirmations sont vraies.
B. Seules les affirmations I à III sont vraies.
C. Seules les affirmations I, III et IV sont vraies.
D. Seules les affirmations I et IV sont vraies.
E. Seules les affirmations III et IV sont vraies.

Solutions

1. C
2. E
3. C
4. D
5. E
6. A
7. E
8. E
9. B
10. C
11. D
12. B
13. D
14. D
15. A
16. B
17. C
18. D

Sources

1. https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/zahlen-fakten/-dl-/fileadmin/downloads/sheets/zahlen-krebs-in-der-schweiz.pdf
2. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/kosten-finanzierung.assetdetail.22324799.html
3. https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/case/d/demography?geoView=table&demoView=graph
4. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Krankheitskosten/_inhalt.html
5. https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/de/alkohol/kennzahlen.html
6. https://www.statistik.at/web_de/services/publikationen/4/index.html?includePage=detailedView&sectionName=Gesundheit&pubId=543
7. https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/gesundheitszustand/index.html
8. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/krankheiten/herz-kreislauf-erkrankungen.assetdetail.19444365.html
9. https://statistik.tg.ch/themen-und-daten/soziales-gesundheit-bildung/gesundheit/lebenserwartung.html/6948
10. https://en.wikipedia.org/wiki/File:HBV_serum_markers.jpg
11. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.html;jsessionid=FCAE447F7FF36D6CD8A895783C60325C.internet082?nn=2379316
12. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/index.html
13. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.21244126.html
14. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.html;jsessionid=FCAE447F7FF36D6CD8A895783C60325C.internet082?nn=2379316
15. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/krebserkrankungen/index.html
16. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.html;jsessionid=FCAE447F7FF36D6CD8A895783C60325C.internet082?nn=2379316
17. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/todesursachen/index.html
18. https://www.euro.who.int/de/publications/abstracts/central-asian-and-eastern-european-surveillance-of-antimicrobial-resistance-annual-report-2018-2018